

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

998/25/၄

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – מתן הסכמה לטיפול רפואי), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 15 א 2. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא :
1. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
- "(ג) היו טיפולים רפואיים נוספים שיתכן שידרש המטופל לעבור בסמוך לטיפול הרפואי שלגביו נתן את הסכמתו ובעקבותיו, יימסר לו מידע רפואי לגביהם ותתבקש הסכמתו מראש גם אליהם."
2. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא :
- "טיפול רפואי המנוי 15א. על אף הוראות סעיף 13, מטפל רשאי לתת טיפול בתוספת ללא רפואי המנוי בפרטים 1 עד 3 לתוספת, שיש נחיצות הסכמה לתתו בנסיבות העניין בתוך פרק זמן קצר, גם כשלא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל אף אם לא מונה לו אפוטרופוס, אם נתקיימו כל אלה :
- (1) מצבו הגופני או הנפשי של המטופל אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת ;
- (2) קרובו של המטופל, לפי סדר הקדימויות שלהלן, נתן הסכמה מדעת לטיפול :

.485' □□, □" □□□; 327' □□, □" □□□□ □" □¹

(א) בן זוגו של המטופל המתגורר עמו, ובלבד שלא ידוע למטפל כי המטופל אינו מעוניין שכן זוגו כאמור יקבל החלטות בעניינו;

(ב) ילדיו הבגירים של המטופל;

(ג) הוריו של המטופל.

(3) לא ידוע למטפל כי המטופל מתנגד לקבלת הטיפול הרפואי;

(4) קיים יסוד סביר להניח שלו המטופל יכול היה לתת הסכמה, היה מסכים לטיפול;

(5) צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל.

תיקון סעיף 16 3. בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) במהלך אשפוז ולפני ביצוע טיפול רפואי כאמור בתוספת, יציע בעל מקצוע מטעם המוסד הרפואי למטופל לחתום על יפוי כוח רפואי כאמור בסעיף קטן (א); לעניין זה, "בעל מקצוע" – רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך."

דברי הסבר

חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996, קובע ככלל כי טיפול רפואי יינתן למטופל רק לאחר קבלת הסכמתו מדעת.

ואולם, סעיף 15 לחוק קובע מצבים שבהם יינתן טיפול רפואי גם ללא הסכמה מדעת של המטופל – בנסיבות של מצב חירום רפואי; אם נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול שיש לתת בהקדם, ועדת האתיקה של בית החולים רשאית לאשר את מתן הטיפול; אם מצבו של המטופל לא מאפשר לקבל את הסכמתו ולא ידוע שהוא מתנגד לכך.

חריג זה לא חל על ניתוחים, צינתורים, דיאליזה וכימותרפיה. לפיכך, על פרוצדורות רפואיות אלה, אם יש צורך בטיפול והאדם אינו יכול לתת הסכמה מדעת, נדרש למנות לו אפוטרופוס.

הדרישה למינוי אפוטרופוס לשם מתן הסכמה לטיפול רפואי כרוכה בקשיים רבים. דרישה זו עלולה ליצור מתחים בין בני המשפחה ואף סכסוכים משפחתיים בשאלה מי ימונה כאפוטרופוס, נדרש לגייס לשם כך את כל בני המשפחה, נדרש תשלום אגרה בסכום גבוה לבית המשפט, נדרש ממי שמיועד להתמנות כאפוטרופוס, לעיתים מספר בני משפחה, להגיע לבית המשפט בשעה שהקרוב לעיתים נמצא במצב קשה בבית החולים.

במטרה לצמצם את מספר המקרים בהם לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל, מוצע להטמיע ולחזק את המנגנונים למתן הסכמת המטופל מראש, באמצעות קביעת חובה להציע לאדם לחתום על יפוי כוח רפואי במהלך אשפוזו או לפני ביצוע פרוצדורות רפואיות מסוימות. כמו כן, מוצע

לקבוע כי תתבקש הסכמה מראש של המטופל לטיפול רפואי שניתן לצפות את הצורך בו מראש, בשל מצבו או בעקבות פרוצדורה רפואית שהוא עובר (כגון טיפולים נדרשים לאחר ניתוח).

בנוסף, מוצע שבמצבים שבהם אין הסכמה מראש או חתימה על יפוי כוח רפואי והאדם אינו מסוגל לתת הסכמה לאותה פעולה רפואית בשעת מעשה, הסכמת בני המשפחה תהווה תחליף למינוי אפוטרופוס וזאת בהתקיים מספר תנאים מגבילים: מצבו של המטופל אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת, ישנה הסכמה מדעת של אחד מקרוביו של המטופל, קיים יסוד סביר להניח כי המטופל היה נותן את הסכמתו לטיפול, הטיפול הרפואי נדרש והוא ישפר את מצב המטופל בצורה ניכרת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3235/20 ; פ/771/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1300/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3337/24).

הצעת החוק זהה לפ/3337/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)